心房中隔脂肪性肥大を早期に指摘し得た１例

◎半田 希空[1)]、関根 綾子[1)]、伊藤 亜衣梨[1)]、加藤 遼[1)]、中森 恵[1)]、中村 真大[1)]、中山 純里[1)]、菊地 良介[1)]
岐阜大学医学部附属病院[1)]

【はじめに】心房中隔脂肪性肥大（Lipomatous Hypertrophy of the Interatrial Septum : LHIS）は，心房中隔に脂肪組織が蓄積する病変であり，被膜を持たない腫瘍様増殖を特徴とする。高齢者や肥満者に多いとされ，基本的に良性疾患であるが，突然死や不整脈との関連も報告されている。

【症例】60 歳代女性。 20XX 年，ふらつきを主訴に他院を受診，精査目的で当院脳神経内科へ紹介となった。小脳性運動失調症の精査過程で施行された PET-CT 検査にて心房中隔に結節状の 18F-fluorodeoxyglucose（FDG）集積を認め，循環器内科へ紹介となった。

【検査所見】経胸壁心エコー図検査（TTE）では，左室駆出率は70%であり，明らかな弁膜症は認められなかった。心房中隔に約 10mm の肥厚所見を認めた。経食道心エコー図検査（TEE）でも，同様に心房中隔に約 10mm の肥厚を認めた。また，卵円窩の肥厚は認められず，明らかなシャント血流は指摘されなかった。心臓単純 CT 検査では，心房中隔に脂肪増生を伴う壁肥厚を認めた。心内膜脂肪と比較し，やや混濁する脂肪織であった。FDG-PET との fusion 画像では，脂肪増生に一致した FDG 集積を認め，LHIS と矛盾しない所見であった。

【考察】LHIS の TTE による診断基準は心房中隔の肥厚が 15mm 以上で，卵円窩を通過する断面で特徴的なダンベル様の形態を示すとされる。本症例は厚さ10mmであったが，CT や FDG-PET の所見が LHIS に矛盾せず，LHIS と診断した。従来の診断基準は 1983 年頃に示されたもので，以後改定されていない。当時は画像解像度が低いため 15mm 以上でなければ診断困難であった可能性があるが，近年は CT や PET などの画像診断能向上により，より早期段階で診断可能となったと考えられる。一般に TTE で心房中隔は心尖部四腔断面で評価困難な場合が多いが，心窩部アプローチにより比較的明瞭に描出できる。多断面評価で心房中隔肥厚を疑った場合，15mm 未満であっても LHIS を念頭に CT など他モダリティでの追加評価を行う必要性が示唆された。

【結語】稀な LHIS の症例を経験した。TTE における心房中隔の多断面評価に加え，従来基準にとらわれない評価の必要性が示唆された。（連絡先 058-230-7261）